

Dyspnoe

- Generell gilt: Kardial, Pulmonal, Zentral, HNO, u.a.
- Entzündlich: Halsabszesse, Epiglottitis, Laryngitis subglottica
- Trauma: Gesichtsverletzungen, Larynxtrauma mit Eintriss, Intubation, Fremdkörper-Aspiration, FK im Rachen, FK im Oesophagus, Ingestion
- Tumore Larynx, Pharynx, Trachea, Oesophagus, Mediastinal
- System: Allergie mit Larynxödem

Lokalisationsdiagnostik, generell gilt:

- inspiratorischer Stridor: Supraglottisch → assoz. mit Dysphagie
- bisphasischer Stridor: Glottisch → assoz. mit Dysphnoie
- expiratorischer Stridor: subglottisch → assoz. mit bellendem Husten
- beidseitige Stimmlippenlähmung

Dysphagie, Odynophagie, Halsschmerzen

- FK im Pharynx
- FK-Ingestion (=FK im Oesophagus) / chemisches Ingestionstrauma (inkl. Pillen!): Dysphagie, Odynophagie, FK-Gefühl, Speicheln!, Atemprobleme
- Mechanisches Trauma
- Akute virale Pharyngitis: Hals/Schluckschmerzen, evt. Katarrh
- Chronische Pharyngitis: Räusperzwang, Reizhusten, FK-Gefühl
- Angina tonsillaris: Fieber, Reflexotalgie, Hals/Schluckschmerzen
- Akute Zungengrundtonsillitis: Schluckprobleme, Schwellung Zungengrund, Atemnot möglich
- Chronische Tonsillitis: rez. Angina oder inapparent, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit, Foetor ex ore
- Scharlach: Hals/Schluckschmerz, Reflexotalgie, Husten, Fieber, LK, Enanthem, Himbeerzunge, Exanthem
- Peritonsillarabszess: massive Halsschmerzen einseitig, Schluckunfähigkeit, Trismus, Fieber
- Parapharyngealabszess: massive Halsschmerzen, Schluckschmerzen, Dysphagie, klossige Sprache, Trismus, Dyspnoe möglich, Fieber
- Retropharyngealabszess: Tortikollis, Dyphagie, Dyspnoe, Halsschwellung, Fieber
- Zungenabszess
- Mundbodenabszess: Schwellung Mundboden + Hals, Zunge nach oben verlagert, Sprech/Schluckstörungen (hot potatoe voice),
- Halsabszess: Halsschwellung, Rötung, Knistern, Fieber, Druckdolenz, Schonhaltung
- Nekrot. Fasiitis: Schlucksz, Dysphagie, Temperatur stark erhöht, progredient gerötete teigige Halsschwellung, septischer Schock mit Organversagen innerhalb Stunden
- Angina plaunt vincent: einseitige Schluckbeschwerden, Foetor ex ore, guter AZ, anguläre LK
- Diphtherie: Beginn mit mässig Fieber, dann AZ-Verschlechterung, Schlucksz, Hals-LK-Schwellung
- Mononukleose: rascher Beginn mit verschlechterung AZ, Fieber, Schwellung Tonsillen und Adenoide mit AW-Obstruktion, Schlucken nicht mehr möglich, LK Hals Axillae und Leiste! Milzschwellung
- Herpangina: Hohes Fieber, Halssz, Dysphagie, herpetiforme Bläschen vorderer Gaumenbogen, Uvula, Tonsillen die Platzen (Ulcer)
- Stomatitis herpetica: Bläschen und Aphten Lippen und Mund, brennend, Fieber
- Angina agranulocytica necroticans: septisches Krankheitsbild, Geschwüre und Nekrosen Tonsillen, Foetor ex ore, keine LK-Schwellung!!
- Candida: guter AZ; Schluckbeschwerden, Brennen, Abstreichbare weisse Beläge auf geröteter Schleimhaut
- Aphthose minor, major, herpetiform, M. Behcet
- Zahnprobleme
- Zahnprothese

- Mundhöhlen-CA: Foetor ex ore, blutige Spucke, selten Schmerzen und Schluckprobleme erst bei Grössenwachstum
- Oropharynx-CA: Hals/Schluckschmerzen, Reflexotalgie, Dysphagie, Speichel blutig, Foetor ex ore, Kieferklemme bei Infiltration Muskulatur, LK-Metastasen
- Dentogene Prozesse v.a. Logenabszesse: Fieber, Schwellung extra/intraoral, Trismus, Eiteraustritt, Dysphagie, Atemnot
- Speicheldrüsenprozesse:
 - o Mumps: Kopfsz, Muskelsz, Anorexie, Sz bei Essen, Trismus
 - o Akut bakterielle Sialadenitis: akuter Beginn, Sz bei Essen, Trismus, diffuse Schwellung der Drüse, Berhärtung der Drüse, Sz bei Palpation, Erythem und eitriges Sekret auf Druck, selten Abszess mit fluktuierender Schwellung
 - o Sialolithiasis: postprandiale Schwellung, Schmerzhaftes Speichelsteinkoliken, Sek. Sialolithiasis
 - o Sjögren: Xerostomie mit Schluckproblemen, Karies, Depapillierter Zunge, diffuse Schwellung der Speicheldrüsen meist bds.
 - o Heerfordt-Syndrom: progressive Parotisschwellung, Uveitis, Fieber, Fazialislähmung
 - o Melkersson-Rosenthal-Symptom: rez. Parotisschwellung, rez. Fazialisparese, Lingua plicata, Makrocheilie, Makroglossie
 - o Rez. Parotiden in der Kindheit: rez. Parotisschwellung z.T. mit Trismus
 - o Postaktinische Sialadenitis: akut Schwellung und Schmerzen, chronisch Atrophie mit Xerostomie
 - o Ranula: Schluck- und Sprechstörungen durch Zysten die Zungenbeweglichkeit behindern
 - o Sialadenose: Xerostomie, Xerophthalmie, bds. Symmetrische Schwellung v.a. Parotis, szlos
 - o Nekrotisierende Sialmetaplasie: Ulkus, v.a. harter Gaumen, DD Plattenepithel-CA
 - o Maligne Tumore: isolierter Knoten, fixiert hart, Sz, Fazialislähmung, Lymphadenopathie, Trismus, rasches Wachstum
- Oesophaguserkrankungen
 - o Achalasie: Dysphagie, Regurgitation
 - o Andere Motilitätsstörungen: Dysphagie, Brustschmerz
 - o Stenosen: Dysphagie, Speiseimpaktion
 - o GERD: Pyrosis, saures Aufstossen, Dysphagie, Extraösophageale Beschwerden (Heiserkeit, Asthma, Husten, Thoraxsz, Zahnschäden, Apnoe)
 - o Tumore: Dysphagie, Gewichtsverlust, Anämie durch Blutungen, Dysphonie bei Rekurrensparese
 - Benigne: Leiomyom, Granulöser Tumor, Papillom
 - Präkanzerose: Barrett (GERD)
 - Maligne: Plattenepithelkarzinom (HNO nah), Adenokarzinom (Magennah)
 - o Hiatale Hernien: meist asymptomatisch
 - o Zenker Divertikel: Dysphagie, Regurgitation unverdauter Speisen, REZ. Aspiration, Halithosis
 - o Epiphrenisches Divertikel: asymptomatisch, Blutungen bei Ulkus
 - o Traktionsdivertikel: asymptomatisch, oe-tracheale Fistelbildung!
 - o Infektiöse Oesophagitis: Odynophagie, Retrosternale Schmerzen, Dysphagie, Fieber, Übelkeit, Erbrechen
 - o Eosinophile Oesophagitis: rezidivierendes Steckenbleiben von Nahrung durch Motilitätsstörungen
 - o GIT-Blutungen: Meläna, Hämatemesis, Hämodynamische Instabilität, Anämie, Synkope, Dyspnoe (häufigste U: Varizen, Refluxoesophagitis, Ulkus, Vask. Malformationen, Aorto-ösophageale Fisteln)

- Intrinsische / extrinsische Oesophagusperforation/ruptur: Schmerzen, Blutiges Erbrechen, subkutanes Emphysem oder Pneumomediastinum, Hämodynamische Instabilität → Cave: Mediastinitis
- + Siehe Dysphonie/Heiserkeit

Kiefer

- Kiefergelenkspathologien: häufig assoziiert mit Kieferklemme oder Kiefersperre, Ohrschmerzen, Gelenksschwellung, Kieferknacken
 - Dysfunktion: Bruxismus: Zahnabrasionen, Muskelhyperplasien, Myoarthropathie
 - Diskopathie:
 - II Anteriore Diskusluxation mit Reduktion: Schmerzen, Gelenksknacken, beginnende Diskusdeformität
 - III: Anteriore Diskusluxation ohne Reduktion: Kieferklemme, Schmerzepisoden, Diskusdeformität
 - IV: Arthrose: Kieferklemme, Krepitationen, Schmerzepisoden
 - Arthritis: infektiös, immunologisch: Morgensteifigkeit, Schwellung, Destruktion, ggf. Rheumafaktor
 - Ankylose: fixierter Trismus
 - Tumor: Funktionsschmerzen, Funktionsgeräusche, Kieferklemme/sperre, Okklusionsstörungen spontan aufgetreten immer Verdächtig!, Mittellinienabweichung bei Mundöffnung
 - Trauma
- Kieferkammatrophy: seichtes Vestibulum, erhöhtes Mundboden, fehlendes Relief, Reduktion Gesichtshöhe, Schmerzen als Folgen Kauinvalidität, Frakturgefahr
- Kieferdysgnathien: Mastikation, Phonetik, Schlucken, Atmung, Parodontale Fehlbelastung, Erschwerte Zahnreinigung, Überbelastung Kiefergelenk, Muskelschmerz, Vertigo, Tinnitus
- Oropharynx-CA: z.T. Trismus bei Infiltration der Muskeln
- Dentogene Prozesse v.a. Logenabszesse: Fieber, Schwellung extra/intraoral, Trismus, Eiterraustritt, Dysphagie, Atemnot
- Mumps
- Akut bakterielle Sialadenitis
- Rez. Parotitiden beim Kind
- Maligne Tumore Speicheldrüsen

Halsschwellungen

- Entzündungen, Infektionen
 - Unspez. Akute Lymphadenitis: reaktiv bei Infekten obere Atemwege v.a. Kinder: weiche, dolente LK
 - Chronisch entzündliche spez. Lymphadenitis: Tbc, Toxoplasmose, Lues, Sarkoidose, DD Malignom!
 - Chronisch entzündliche Arzneimittel-Lymphadenopathie: indolente LK, sitiert bei Mediabsetzen
- Benigne Neoplasien
 - Lipom: weich, indolent, diffus, elastisch
 - Madelung'scher Fetthals: diffuse Proliferation Lipozyten am Hals, Nacken, Oberarmen
 - Schwannom/Neurinom: Schwellung, selten Dysfunktion v.a. Plexus brachialis, N. Vagus
 - Glomus caroticum Tumor: Tumor Chemorezeptorzellen in Carotisgabel, selten neuroendokrin aktiv mit BD-Entgleisungen
 - Hämangiome: Rötlich, z.T. Farblos wenn in Tiefe
 - Fibrome
 - Lymphangiome

- Maligne Neoplasien
 - Metastasen: meist HNO-Tumor ass. Alk/Nikotin, solitär indolente harte LK-Schwellung die therapieresistent ist
 - Lymphome: solitär oder generalisierte Lymphadenopathie, ggf. Befall Waldeyer-Rachenring, B-Symptome
 - Sarkome
- Missbildungen
 - Laterale Halszyste/Sinus: 15.-25. LJ i.R. Infekt
 - Laterale Halsfistel: ab Geburt
 - Beide: Schwellung zw. Os hyoideum und Vorderrand des Sternocleidomastoideus meist 2 Finger oberhalb Claviculargelenk
Fistelöffnung aussen: Vorderrand SCM, innen: Tonsillenregion, Sinus piriformis
 - Mediane Halszyste/Fistel: meist vor 6. LJ, meist innerhalb 1. LJ
 - Prallelastische indolente Vorwölbung oberhalb Os hyoideum
Zyste: obligat dass sie den Bewegungen Os hyoideum bei Schlucken folgt
Fistel: innen: Zungengrund Foramen caecum, aussen: Haut
 - Äussere Laryngozele: „Blähhals“, Bei Pressen kommt es zur Vorwölbung durch Luftfüllung der Zele, Globusgefühl, Dysphagie
- Schilddrüsenprozesse
 - Struma
 - Knoten
 - Maligne Tumore: papilläres CA, follikuläres CA, anaplastisches CA, medulläres CA
 - Entz: Hashimoto, Thyreoiditis de Quervain, bakterielle Thyreoiditis
- Speicheldrüsenprozesse v.a. Parotis
 - Mumps
 - Akut bakterielle Sialadenitis
 - Sialolithiasis
 - Sjögren: diffuse Halsschwellung
 - Heerfordt-Syndrom
 - Melkersson-Rosenthal-Syndrom
 - Rez. Parotitiden beim Kind
 - Postaktinische Sialadenitis
 - Sialadenose
 - Tumore Speicheldrüsen (isolierter Knoten)
 - Frey-Syndrom: Rötung Parotis und Wangenschwitzen bei Essen postoperativ nach Parotidektomie
- Traumatisch
 - Aneurysma
- Kieferprozesse
- Dentogene Prozesse v.a. Logenabszesse: Fieber, Schwellung extra/intraoral, Trismus, Eiterraustritt, Dysphagie, Atemnot

Heiserkeit/Dysphonie → Larynxprobleme meist assoz. Mit Schluckstörungen, Dyspnoe

- FK-Aspiration, FK im Pharynx
- Ingestionstrauma
- Mechanisches Trauma
- Infekt der oberen Atemwege: Nase: Verstopft, hyponasale Resonanz, Larynx: Schmerzen, Schleim, Larynx: Schleimhautschwellung, Rötung, Schleimhautauflagerung, Schwingungsamplituden vermindert, Randkanten vibration vermindert, SL-Schluss inkomplett, rauhe belegte heisere Stimme, Stimmermüdung, Singen nur mit Druck
- Akute Laryngitis: Stimme heiser, rau, belegt, matt, klangarm, eingeschränkt belastbar, Reizhusten

- Chronische Laryngitis: Heiserkeit, FK-Gefühl, Räusperzwang, Reizhusten, Stimme tiefer geworden
- Kruppsyndrome:
 - o Diphtherie
 - o Bakterielle Laryngotracheitis: allmählicher Beginn nach Rhinitis, Pharyngitis, in-exspiratorischer Stridor, produktiver Husten, rauhe heisere aphone Stimme, Schlucksz, mässig Fieber, Leukozytose, pulmonale RG's
 - o Subglottische Laryngitis (Pseudokrupp): allmählich inspiratorischer Stridor, Atemnot, Zyanose, abends/nachts bellender rauer Husten, raue Heisere Stimme, Schlucken nicht beeinträchtigt, subfebril, keine Leukozytose
 - o Epiglottitis: plötzlicher Beginn, lauter inspiratorischer Stridor mit Atemnot, Heisterkeit und Husten können fehlen, Schlucksz, hohes Fieber, Leukozytose, Gefahr Erstickung innerhalb Stunden
- Einseitige Stimmlippenlähmung: Heiserkeit
- Larynx-CA (v.a. >3 Wochendauernde Heiserkeit immer abklären!): Heiserkeit, später Dyspnoe Dysphagie Reflexotalgie möglich
- Hypopharynx-CA: Heiserkeit erst sehr spät bei Larynxmitbefall! Primär Foetor, Reflexotalgie, Schluckstörungen, LK-Metastasen meist Erstsymptom
- Gutartige Tumore:
 - o Papillom: Heiserkeit, behauchte Stimme, himbeerartige RF, gelegentlich Dyspnoe
 - o SL-Zyste: intrachordale RF einseitig, Heiserkeit wechselnden Ausmasses mit rauher Stimme, leicht diplophon
 - o SL-Polyp: Heiserkeit, Diplophonie, gestielte oder breitbasige RF meist einseitig in vorderen 2/3 der SL, Flottiert
- Funktionelle Dysphonie → keine URSÄCHLICHE organische Veränderung Kehlkopf, evt. sek. Organische Veränderungen am Kehlkopf
 - o SL-Knötchen: Stimme Heiser, behaucht, braucht viel Druck, doppelseitige Knötchenbildung an korrespondierenden Stellen, Sanduhrglottis mit verminderter Randkantenverschiebung
 - o Psychogene Dysphorie: keine morphologischen Veränderungen, Koordination Atmung-Stimmgebung-Artikulation gestört
- Oesophagus-CA bei Rekurrensparese
- GERD

Epistaxis Anamnese

- Dauer, Seite
- Blutung nach vorne/hinten
- Übelkeit (durch Blut verschlucken)
- Blutungsmenge
- Einmalig, häufiger, rezidivierend
- Bisherige Therapie
- Lokale Ursachen: Anatomische Deformitäten, Atrophische Schleimhaut bei älteren, Trauma (Nasenbohren), entzündliche Reaktion (Sinusitiden, Allergie), Inhalationsdrogen, Tumore (v.a. bei rez. Epistaxis daran denken!!), nasale Steroide,
- Systemische Ursachen: Hypertonie, Medikamente (ASS, Marcoumar), hämorrhagische Diathesen, Alkohol

Endokarditisprophylaxe? Allergien?

Rhinorrhö

- Angeboren: einseitige Choanalatresie mit eitriger Sekretion
- Infektiös:
 - o Akute Rhinitis/Rhinosinusitis

- Infektiös: viral, seltener bakteriell, selten Pilze, dentogen
- Nicht-infektiös: allergisch, toxisch, FK, Tumor, hormonell, posttraumatisch, Barorhinitis
- o Chronische Rhinitis/Rhinosinusitis
 - Unspez: rezidivierend infektiös, Septumdeviation, Septumsporn, Nasenmuschelhyperplasie, Polypen, Tumore, Adenoide
 - Spez: Tbc, Wegener, Rhinosklerom, Malleus Rotz, hormonell, medikamentsö, irritativ-toxisch, vasomotorisch, Sarkoidose, Syphilis, Mykosen
- Trauma, Toxisch :
 - o FK in Nase → einseitig eitrig Rhinorrhö
 - o Pyramidenquer/längsfraktur (Liquorinorrhö)
- Malign Tumore Nasenhöhle/NNH: blutige Rhinorrhö, Foetor e naso, einseitige NAB, therapieresistente Sinusitiden, später ophthalmologische Probleme (Protrusio, Doppelbilder..)

NAB

- Choanalatresie
- Septumdeviation
- Hyperplastische Nasenmuschel (v.a. inferiore)
- Akute Rhinitis/Rhinosinusitis
 - o Infektiös: viral, seltener bakteriell, selten Pilze, dentogen
 - o Nicht-infektiös: allergisch, toxisch, FK, Tumor, hormonell, posttraumatisch, Barorhinitis
- Chronische Rhinitis/Rhinosinusitis
 - o Unspez: rezidivierend infektiös, Septumdeviation, Septumsporn, Nasenmuschelhyperplasie, Polypen, Tumore, Adenoide
 - o Spez: Tbc, Wegener, Rhinosklerom, Malleus Rotz, hormonell, medikamentös, irritativ-toxisch, vasomotorisch, Sarkoidose, Syphilis, Mykosen
- Adenoide
- Benigen Tumore Nasenhöhle/NNH: invertiertes Papillom, Osteom, Angiofibrom
- Malign Tumore Nasenhöhle/NNH: blutige Rhinorrhö, Foetor e naso, einseitige NAB, therapieresistente Sinusitiden, später ophthalmologische Probleme (Protrusio, Doppelbilder..)
- Nasopharynx-CA: einseitiger Paukenerguss, Lk-Metastasen, NAB, Epistaxis, selten Hirnnervenlähmungen

Riechstörungen

- Qualitativ: Parosmie, Phantosmie, Kakosmie
 - o Parosmie:
 - Postviral
 - Posttraumatisch
 - o Phantosmie
 - Tumore
 - Psychiatrisch
 - Neurologisch (MS, Insult ..)
- Quantitativ: Hyposmie, Anosmie, Hyperosmie, spez. Anosmie
- Anosmie/Hyposmie
 - o Chronische Nasenprobleme
 - Septumdeviation
 - Muschelhyperplasie
 - Polypen
 - Akute Rhinitis/Rhinosinusitis → reversibel vs. permanent
 - Infektiös: viral, seltener bakteriell, selten Pilze, dentogen

- Nicht-infektiös: allergisch, toxisch, FK, Tumor, hormonell, posttraumatisch, Barorhinitis
- Chronische Rhinitis/Rhinosinusitis → reversibel vs. permanent
 - Unspez: rezidivierend infektiös, Septumdeviation, Septumsporn, Nasenmuschelhyperplasie, Polypen, Tumore, Adenoide
 - Spez: Tbc, Wegener, Rhinosklerom, Malleus Rotz, hormonell, medikamentsö, irritativ-toxisch, vasomotorisch, Sarkoidose, Syphilis, Mykosen
- Tumor
 - Traumatisch: Abriss Fila olfactoria
 - Schädigung Riechepithel: Toxisch (SO₂, NO, Ozon), Medikamente, virale Infekte, Strahlentherapie
 - Kongenital: Bulbus olfactorius Aplasie (Kallmann-Syndrom mit Infertilität und Bulbusaplasie)
 - Neurologisch
 - Tumore: plötzliche Anosmie ohne Erklärung immer daran denken!
 - Parkinsons: häufig Erstsymptom!
 - Idiopathisch

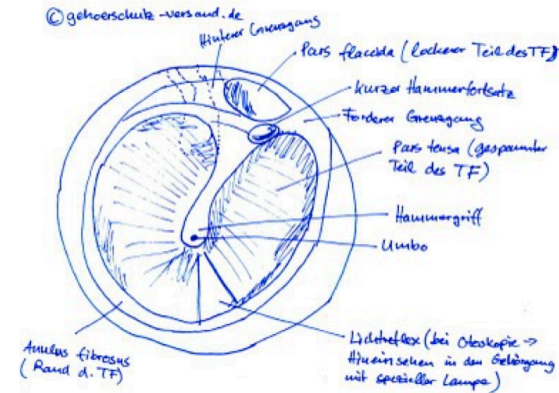
Geschmacksstörungen

Ageusie/Hypogeusie/Hypergeusie, Parageusie, Phantogeusie:

- Neurologisch peripher: Fazialisparese, postoperativ, Otologie, Tonsillektomie, orale Operationen (Chorda tympanie, N. vagus, N. glossopharyngeus, N. lingualis V3)
- Neurologisch zentral: Fazialisparese, Hirnschlag, Schädelhirntrauma, MS, Tumore
- Mangelernährung: Zink, Vit B3, Vit B12, Eisen, Kupfermangel, Kachexie
- Systemerkrankungen: Karzinome (HNO, Bronchus, Paraneoplasie), Niereninsuffizienz, Leberinsuffizienz, DM, Sicca-Syndrom
- NW: Radio-/Chemotherapie, Meidkamente
- Postinfektiös
- idiopathisch

Gesichtsschmerz

- Akute Rhinitis/Rhinosinusitis
 - Infektiös: viral, seltener bakteriell, selten Pilze, dentogen
 - Nicht-infektiös: allergisch, toxisch, FK, Tumor, hormonell, posttraumatisch, Barorhinitis
- Chronische Rhinitis/Rhinosinusitis
 - Unspez: rezidivierend infektiös, Septumdeviation, Septumsporn, Nasenmuschelhyperplasie, Polypen, Tumore, Adenoide
 - Spez: Tbc, Wegener, Rhinosklerom, Malleus Rotz, hormonell, medikamentsö, irritativ-toxisch, vasomotorisch, Sarkoidose, Syphilis, Mykosen
- Kopfschmerzen
- Trauma: Mittelgesichtsfrakturen



Schallleitungsschwerhörigkeit

- Aussenohr:
 - Cerumen obturans: v.a. nach Duschen/Baden durch Aufquellung
 - Gehörgangskollaps
 - Fremdkörper im äusseren Gehörgang → TF-Perforation, Otitis media, N. facialis Störung, Schwindel, Nystagmus ausschliessen!
 - Gehörgangshyper/exostosen
 - Fehlbildungen/Dysplasie der Ohrmuschel
 - Gehörgangsatresie/stenose
 - Tumor äusserer Gehörgang
 - Otitis externa diffusa, circumscripta, necroticans, bullosa
 - Felsenbeinlängsfraktur: Blut im Gehörgang, TF gerissen, Otorrhö, Rhinoliquorrhö, Transmissionsschwerhörigkeit bei Dislokation Ossikel, gelegentlich Gesichtsnervenlähmung 10-20% v.a. Spätparesen
- Mittelohr:
 - Otosklerose: zu Beginn langsam progressive Schallleitungsschwerhörigkeit (v.a. SS), evt. Tinnitus, später auch Innenohrschwerhörigkeit, pos FA
 - Trauma
 - Otitis media simplex: nach viralem Infekt, Ohrschmerzen, Hörminderung, Fieber, Hörminderung kann Wochen weiterbestehen
 - Otitis media chronica seromucosa: entzündlicher nicht infizierter Erguss bei intaktem TF ohne akute Ohrsymptome, kein Krankheitsgefühl, Leitsymptom Hörverlust
 - Otitis media chronica perforata simplex: zentrale TF-Perforation, trocken (keine Entzündungszeichen), feucht (Entzündungszeichen → Otorrhö, Sz, Schwellung), szlose Hörminderung
 - Otitis media chronica perforata cholesteatomatosa: randständige TF-Perforation bei sek. Erworbenem Cholesteatom, szlose Hörminderung, Nässende Form: Otorrhö bei akutem Infekt, trockene Form: keine Symptome erst bei Komplikationen,
 - Traumatische TF-Perforation milde Schwerhörigkeit, bei Beteiligung Ossikula schwere Schwerhörigkeit (Luxation, Fraktur)
 - Barotrauma
 - Nasopharynx-CA: Paukenerguss im Frühstadium!

Schallempfindungsschwerhörigkeit

- Kongenitale Innenohrschwerhörigkeit:

- Genetisch: AR, AD, X-chromosomal, mitochondrial: sprunghafte Zunahme rezidivierende Hörstörze oder langsame Progredienz
- Infekte
- Erworben
 - Cochleär:
 - Presbyakusis (>50 J idiopathisch): zu Beginn v.a. Sprachverständnis gestört bei Umgebungslärm, dann progressiv
 - Idiopathische chronisch-progressive Innenohrschwerhörigkeit (<50 J idiopathisch)
 - Hörsturz: idiopathisch, plötzlich, einseitig OHNE äusseren Einfluss, häufig Tinnitus
 - Akutes akustisches Trauma (C4-Senke): Knalltrauma, Airbag
 - Explosionstrauma: Druckwelle
 - Akute Lärmschwerhörigkeit: Konzert, Düsentriebwerk, z.T. reversibel
 - Chronische Lärmschwerhörigkeit: Grenzwertüberschreitung 90db>8h/d
 - Toxisch:
 - Ototoxische Medikamente: Aminoglykoside, Cisplatin, Furosemid, Salicylate
 - Alkohol, Heroin, Kokain
 - Metalle: Blei, Arsen, Quecksilber
 - Aminobenzole
 - Traumatische Innenohrschädigung
 - Felsenbeinquerfraktur: intaktes TF mit Hämatotympanon, Schwindel, Nystagmen, Perzeptionsschwerhörigkeit, Fazialislähmung in 50% (v.a. direkte, schlechte Prognose!), evt. Rhinoliqorrhö
 - M. Menière
 - Labyrinthitis tympanogen
 - Zoster oticus: Prodromi (Sz, Brennen), Bläschen → Krusten, z.T. Schallempfindungsschwerhörigkeit, Nystagmus, Schwindel, Gleichgewichtstörungen, Fazialisparese!
 - Otitis externa necroticans, bullosa
 - Otitis media mit Innenohrbeteiligung
 - Lues, Borrelien..
 - Labyrinthitis meningeal
 - Meningitis mit descendierender Infektion
 - Labyrinthitis hämatogen
 - Mumps, Masern, CMV, Lues, Borreliose..
 - Akuter Labyrinthinfarkt (vertebrobasiläres Stromgebiet)
 - Otosklerose: zu Beginn langsam progressive Schalleitungsschwerhörigkeit, evt. Tinnitus, später auch Innenohrschwerhörigkeit
 - neural/retrocochleär:
 - Tumore die Hörnerv komprimieren (Kleinhirnbrückenwinkel → Akustikusneurinom) v.a. Tinnitus, Hörverlust, Dysakusis, selten vestibuläre Symptome, BAEP, MRT
 - MS mit Befall Hörnerv
 - Insult

Ohrenschmerzen

- Äusseres Ohr
 - Fisteln/Zysten die entzündet sind
 - Othämatom (Ringerohr) → Ausschluss Verletzungen Schläfenbein, Kiefer, Gehörgang, DD Polychondritis

- Ohrmuschellazeration/abriss → Ausschluss Verletzungen Schläfenbein, Gehörgang, Mittelohr, Kiefergelenk
- Fashion-Injury : kein Knorpelschaden
- Verbrennung / Erfrierung (erst bei Wiedererwärmung Sz)
- Gehörgangsverletzung
- Akute Entzündung Auricula: akute Sz (Ohrmuschelzugsz, Tragusdrucksz)
 - Perichondritis: auf Knorpel beschränkt, Ohrläppchen ausgespart, starke Sz, Ohrmuschelkonturen verstrichen (Schwellung des Ohres), Druckdolenz, z.T. Fieber
 - Dermatitis: auf Dermis beschränkt, rotes ekzematöses Ohr inkl. Ohrläppchen (Papulovesikel), Ohrkonturen erhalten, wenig Sz, Juckreiz, Brennen, nässend oder schuppig-trocken, kein Fieber
 - Erysipel: Rötung, Schwellung, Ohrkonturen verstrichen, Überwärmung der gesamten Ohrmuschel inkl. Ohrläppchen, Fieber, Fortschreitend/Ausdehnend
 - Zoster oticus: Prodromi (Sz, Brennen), Bläschen → Krusten, z.T. Schallempfindungsschwerhörigkeit, Nystagmus, Schwindel, Gleichgewichtstörungen, Fazialisparese!
 - Rez. Polychondritis (Autoimmung): Formveränderungen Ohr Nase
 - Gichtophi
 - Chondrodermatitis Winkler: szhaftes Knötchen mit zentralem Nabel Helix/Antihelix
- Akute Entzündungen Gehörgang: Ohrmuschelzugschmerz, Tragusdrucksz
 - Otitis externa diffusa: Juckreiz, Sz, Otorrhö, Schalleitungsschwerhörigkeit
 - Otitis externa circumscripta: Furunkelähnlich stark Szhaft, Druckdolent, leichte Schwerhörigkeit
 - Otitis externa necroticans: fehlende Heilungstendenz einer Otitis externa, Sz zunehmend, fétide Otorrhö
 - Otitis externa bullosa: heftiger Sz plötzlich, blutige Otorrhö
 - Otitis externa specifica (Lues, Tbc ..)
 - Gehörgangsmykose: starker Juckreiz, Vollegefühl des Ohres, ggf. TF-Perforation
 - Dermatitis
 - Bläschen: Zoster oticus
- Tumor Ohrmuschel: Basaliom Spinaliom, Melanom, aktinische Keratose, M. Bowen, seborrhoische Keratose..
- Tumore Gehörgang: szhafte, nicht heilende Veränderungen immer verdächtig (v.a. Plattenepithel-CA)
- Mittelohr:
 - Otitis media simplex: nach viralem Infekt, Ohrschmerzen, Hörminderung, Fieber
 - (Otitis media chronica seromucosa: entzündlicher nicht infizierter Erguss bei intaktem TF ohne akute Ohrsymptome (kein Krankheitsgefühl), Leitsymptom Hörverlust)
 - (Otitis media chornica perforata simplex: zentrale TF-Perforation, trocken (keine Entzündungszeichen), feucht (Entzündungszeichen → Otorrhoe, Sz, Schwellung), Hörminderung)
 - (Otitis media chronica perforata cholesteatomatosa: randständgige TF-Perforation bei sek. Erworbenem Cholesteatom, Hörminderung, Nässende Form: Otorrhö bei akutem Infekt, trockene Form: keine Symptome erst bei Komplikationen)
 - traumatische TF-Perforation: Sz, blutige Otorrhö, ggf. vestibuläre Symptome und Fazialisparese
 - Barotrauma
- Reflexotalgie bei Tonsillitis/Pharyngitis/Angina: Ohrenschmerzen v.a. bei Schlucken

- Reflexotalgie bei Larynx/Hypopharynx/Oropharynx-CA
- Kiefergelenkspathologien

Otorrhö

- Äusseres Ohr
 - o Lang verbleibende FK (fötide Otorrhö)
 - o Gehörgangsverletzungen (FK, Manipulation) meist blutig, Begleitverletzungen TF, Mittelohr, Kiefergelenk ausschliessen
 - o Otitis externa (eitrig), Otitis externa bullosa (blutig)
 - o Tumore Gehörgang blutige Otorrhö möglich
 - o Felsenbeinlängsfraktur: Blut im Gehörgang, TF gerissen, Otoliquorrhö, Rhinoliquirrhö, Transmissionsschwerhörigkeit bei Dislokation Ossikel, gelegentlich Gesichtsnervenlähmung 10-20% v.a. Spätparesen
- Mittelohr
 - o Otitis media simplex mit TF-Perforation
 - o Otitis media chronica perforata simplex: zentrale TF-Perforation, trocken (keine Entzündungszeichen), feucht (Entzündungszeichen → Otorrhoe, Sz, Schwellung), Hörminderung
 - o Otitis media chronica perforata cholesteatomatosa: randständige TF-Perforation bei sek. Erworbenem Cholesteatom, Hörminderung, Nässende Form: Otorrhö bei akutem Infekt, trockene Form: keine Symptome erst bei Komplikationen
 - o traumatische TF-Perforation: Sz, blutige Otorrhö, ggf. vestibuläre Symptome und Fazialisparese

Tinnitus

- Äusseres Ohr
 - o Cerumen obturans v.a. nach Duschen/Baden
 - o FK im äusseren Gehörgang
- Mittelohr:
 - o Otosklerose
 - o Klaffende Tube/Eustachi-Dysfunktion : Tinnitus v.a. bei Anstengung, im Liegen besser, unangenehmer Ohrdruck
 - o Glomustumor: Gefässmissbildung mit pulsatilem Tinnitus
- Innenohr
 - o Akutes akustisches Trauma (C4-Senke): Knalltrauma, Airbag
 - o Explosionstrauma: Druckwelle
 - o Akute Lärmschwerhörigkeit: Konzert, Düsentriebwerk, z.T. reversibel
 - o Chronische Lärmschwerhörigkeit: Grenzwertüberschreitung 90db>8h/d
 - o Labyrinthitis tympanogen, menigeal, hämatogen
 - o Toxische Innenohrschädigung
 - o Akuter Labyrinthinfarkt (vertebrobasiläres Stromgebiet)
 - o Hörsturz häufig mit Tinnitus
 - o Morbus Menière
-
- Hörbahn
 - o Tumore die Hörnerv komprimieren (Kleinhirnbrückenwinkel → Akustikusneurinom) v.a. Tinnitus, Hörverlust, Dysakusis, selten vestibuläre Symptome, BAEP, MRT
- Zentral
 - quantifizieren (objektiv, subjektiv, kompensiert, dekomensiert, akut-chronisch)

Schwindel

Vestibulär bedingt: ausgeprägt Nausea+Erbrechen, heftige Intensität, Richtungsbestimmter Schwindel, Kalorik gestört, Kopfpulstest pathologisch

- akutes Vestibuläres Syndrom: >24h, Tage bis Wochen, Zunahme bei Bewegung
 - o Neuritis vestibularis: akut, einseitiger Vestibularisausfall, einmaliges Ereignis, heftiger permanenter Drehschwindel, starke Gangunsicherheit, Nausea und Erbrechen, keine Auslöser, keine andere Ohrsymptomatik, oft nach viralem Infekt, horizontaler richtungsbestimmter Spontannystagmus zur gesunden Seite, Kopfpulstest pathologisch auf abnormal erkrankter Seite, Kalorik untererregbar, Romberger und Unterberger Fallneigung zur betroffenen Seite, normales Gehör
Verlauf: zentrale Kompensation, Abnehmende Beschwerden da einseitig
- Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel: Sekunden-Minuten, Ausgelöst durch Kopfbewegung/Lagerung in Ebene des erkrankten Bogengangs, Drehschwindel, rezidivierende Anfälle während Tagen bis Wochen auch Nachts möglich! Dix-Hallpike-Manöver zur Diagnosestellung mit rotatorischem Nystagmus, meist hinterer Bogengang Kanalo/Kupulolithiasis, St. N. Schädeltrauma, Vestibularis Neuritis, idiopathisch
Th: Epley-Manöver, Semont-Manöver
- M. Menière: Trias: Stunden dauernder Schwindel (<24h)+Tinnitus+Fluktuierende Schwerhörigkeit (Schallempfindungsschwerhörigkeit) i.d.R. einseitig, kein Auslöser, z.T. drop attack (Stürze ohne Bewusstlosigkeit), Kalorik untererregbar, Perzeptionsschwerhörigkeit im Tiefenbereich, normaler AEP, mehrere Anfälle über Jahre mit wechselndem Intervall
- Bilaterale Vestibulopathie: beidseitige Unterfunktion mit Gleichgewichtsstörungen, Betrunkenheitsgefühl, Oszillopsien, Verstärkung in Dunkelheit, KEIN Spontannystagmus da beidseits!, Kopfpulstest pathologisch, Kalorik untererregbar
 - o Missbildung Innenohr
 - o Spätstadium Otosklerose bds
 - o Felsenbeinquerfraktur bds: intaktes TF mit Hämatotympanon, Schwindel, Nystagmen, Perzeptionsschwerhörigkeit, Fazialislähmung in 50% (v.a. direkte, schlechte Prognose!), evt. Rhinoliquirrhö
 - o Labyrinthitis bds menigeal, hämatogen)
 - o Ototoxische Substanzen

Nicht-vestibulär bedingt: wenig Nausea, geringere Intensität, Ungerichtet (Täumelig)

Wenn zentral: HINTS: Kopfpulstest normal, Blickrichtungsnystagmus, alternierender Covertest mit Vertikaldivergenz

evt. bei Kleinhirn: Dysdiadochokinese, Rebound, FNV, KHV

evt. bei Propriozeption: gestörte Sensibilität, Zunahme Schwindel bei Dunkelheit

evt. bei Hirnstamm: Hirnnervenausfälle möglich

- akutes zentrales vestibuläres Syndrom: >24 h, Tage bis Wochen, Zunahme bei Bewegung
 - o Infarkt Hirnstamm, Cerebellum: HINTS
- Andere Ursachen:
 - o MS
 - o Enzephalitis
 - o Tumore
 - o Wenicke-Korsakow-Syndrom
 - o Hirnstammkontusion
 - o Basilarismigräne

Fazialisparese

- Zentral: Stirnastfunktion erhalten! → immer kompletter Neurostatus!
- Peripher: Stirnastfunktion nicht erhalten: Hyperakusis, Otalgie, Geschmacksstörungen, Störungen Tränensekretion, Störung mimische Gesichtsmuskulatur
 - o Idiopathisch: Bell-Parese

- Entzündlich, infektiös: Mittelohrprozesse, v.a. Otitis media acuta, Cholesteatom, Otitis externa necroticans, Herpes Zoster, Borreliose, Tbc, Mononukleose, HIV
- Traumatisch: Felsenbeinquerfraktur (v.a. Frühe), Felsenbeinlängsfraktur (v.a. Späte)
- Neoplastisch: Tumore Glandula parotis, Fazialisneurinom, Schwannom, ..
- Metabolisch: DM; Schwangerschaft